

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	心衰竭 Heart Failure				
	編號	制定者	核准者	公布日期	修正日期
	A31000-Q03-W-B17	CCU 林炳蓁	吳姿蓉	98 年 05 月 31 日	115 年 01 月 06 日
制定單位	護理部	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.9 版/11 頁				

一、目的

讓護理人員了解心衰竭的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

心臟衰竭(Heart Failure)乃指患者於臨床上有著典型心臟衰竭症狀（例如呼吸困難、腳踝腫脹和疲勞），且可能伴隨著客觀之徵象（例如頸靜脈壓升高、肺劈啪聲和外周水腫），由心臟功能上或結構上的異常而引起患者在運動或休息時，心輸出量下降或心內壓增加。

（二）症狀

典型症狀：呼吸短促、端坐呼吸、陣發性夜間呼吸困難、活動耐受度降低、活動後疲勞、疲倦時間變長及腳踝腫脹等症狀。

非典型症狀：夜間咳嗽、喘息、腫脹的感覺、食慾不振、混亂（尤其是在老年）、沮喪、心悸、頭暈、昏厥及彎腰呼吸急促症等症狀。

（三）常見檢查

1. 實驗室檢查（含動脈血氣體分析）
2. 胸部 X 光檢查：心衰竭時在 X 光上可看到心臟擴大、肺部血流重新血流分布及

主題名稱	心衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/12

血管腫大、間質性肺水腫、肺泡浸潤、肺積水等。在二尖瓣狹窄(MS)亦可發生肺水腫、左心房腫大，但通常沒有心臟擴大。而心臟擴大卻沒有明顯的肺水腫則可能為心包膜積水或右心衰竭。

3. 心電圖檢查：心衰竭時常呈非特異性變化，如倒立的 T 波、心室纖維顫動(atrial fibrillation)、心室肥大(LVH)或心房擴大等。
4. 心臟超音波：加上都普勒流速檢查，可幫助找出心臟衰竭的原因。例如瓣膜的檢查、評估代償機制（心室擴大、肥厚等）運作的情形，評估整體或部分心室收縮的情形。此外，核子醫學亦可檢查心室大小及心壁運動的情形，可算出射出率(ejection fraction)，並可藉操作誘發試驗（如跑步）來評估早期心室功能損壞的情形。
5. 運動心電圖
6. 心血管攝影、心導管檢查
7. 核子醫學檢查：可檢查心室大小及心壁運動的情形，可算出射出率(ejection fraction)，並可藉操作誘發試驗（如跑步）來評估早期心室功能損壞的情形。
8. 電腦斷層檢查：以非侵入性的方法檢查冠狀動脈的情形，準確偵測冠狀動脈疾病。

（四）常見治療

1. 藥物治療：

(1) 血管收縮素轉酵素抑制劑(ACEI)：

作用：血管擴張、降低血壓，減輕心臟負荷。

副作用：頭暈、乾咳、血鉀升高。

(2) 血管收縮素受體阻斷劑(ARB)

作用：降低血壓，減輕心臟負荷。

副作用：嗜睡、頭痛、腹瀉。

(3) 利尿劑

作用：排除體內過多水份，減輕心臟負擔。

主題名稱	心衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/12

副作用：腎功能變差。

(4) BETA 阻斷劑

作用：減慢心跳及降低血壓，減輕心臟負擔。

副作用：心跳變慢、低血壓。

(5) 中性溶酶抑制劑 ARNI（健安心 Entresto）

作用：抑制腎素、血管張力素系統，抑制血管收縮、降低血壓、延緩心臟肥大。

副作用：低血壓、高血鉀。

(6) 心跳節律抑制（康立來 Coralan）

作用：降低心跳減少心臟的負擔，若心跳小於 50 次/分，立即停藥。

副作用：心跳過緩、視力模糊。

(7) 毛地黃（隆我心 Digoxin）

作用：增加心臟收縮，提高心輸出量，吃藥前先量心跳，少於 60 次分應報告醫師；注意中毒症狀如食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、畏光、視力模糊、視野變黃、心律不整。

2. 飲食治療：

採少量多餐，禁燉補，應選擇易消化、營養成分佳的天然食物，並控制飲食中的鹽分（鈉）及水，每日限制鹽勿超過 3 至 5 公克等同 1200 至 2000 毫克的鈉。不是只有鹽才有鈉市售加工品、調味料都有鈉，如味增、沙茶醬、味精、醬油、調味料、各式醬料、罐頭及醃製食品、肉乾、香腸、臘肉等應減量或避免食用。

水分調整部分，避免體液過度增加，加重心臟負荷惡化心衰竭。應調整水分攝取 1000 毫升至 1500 毫升／天，依照尿量及疾病狀況調整三餐平均每餐可攝取 330 毫升至 500 毫升且包括所有食物含水量及液體。

（五）護理問題

1. 低心輸出量／與機械運動功能異常所致的心搏出量下降有關。

主題名稱	心衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/12

2. 氣體交換困難／與氧的供給改變有關。
3. 體液容積太多／與心肌收縮力減弱有關。
4. 活動耐力不足／與氧的供需不平衡、疲憊或電解質障礙有關。
5. 焦慮感受／與呼吸困難有關。

(六) 護理措施

1. 低心輸出量／與機械運動功能異常所致的心搏出量下降有關：
 - (1) 密切監測心跳速率及節律、血壓、皮膚顏色及溫度、四肢脈搏跳動強度及意識狀態等。
 - (2) 聽診心音，若出現 S3 或 S4 時通常是心臟衰竭的早期徵象（S3：胸骨左緣第五肋間；S4：左鎖骨中線第五肋間處）。
 - (3) 至少每 8 小時監測並記錄病人的攝入排出量。
 - (4) 每日測量體重，是否有不正常的增加($\pm 10\%$)。
 - (5) 維持臥床休息以減少氧氣消耗量，並抬高床頭 30-60 度，以利胸廓擴張及換氣進行。
 - (6) 當出現端坐呼吸嚴重時，可協助病人臥在床上休息。
 - (7) 在急性期時讓病人臥床休息，以減低心臟負擔及心肌耗氧量，但臥床期間應避免血栓的發生。
 - (8) 限制訪客次數及時間，並安排寧靜環境讓病人獲得完全休息。
 - (9) 注意病人的安全，因大多數病人會採臥床休息所以易出現姿勢性低血壓，故避免迅速移動位置或姿勢，並於病人活動時，應監測其心跳速率、血壓及呼吸速率的變化。
 - (10) 密切評估藥物使用療效，如：強心劑、利尿劑、抗心律不整藥物及血管擴張劑等。
2. 氣體交換困難／與氧的供給改變有關
 - (1) 密切評估意識狀況、呼吸音及皮膚黏膜顏色。

主題名稱	心衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/12

(2) 抬高床頭，協助病人採半坐臥姿，並使其頸部有適度的支托，以利肺部擴張。

(3) 依醫囑給予氧氣使用並評估療效，置病人於換氣和灌流能達最佳狀態的姿勢，例如：半坐臥、坐臥。

(4) 教導病人翻身、咳嗽、深呼吸以利呼吸道分泌物之清除。

(5) 監測動脈血液氣體分析值之變化，並矯正血氧過低或酸中毒之症狀。

(6) 如果病人出現呼吸衰竭情形，則需準備協助置入氣管內管，或使用呼吸輔助器。

(7) 監測組織缺氧的徵象：心智狀況改變、心跳過速、易怒和異常呼吸音，並報告醫師。

(8) 每小時監測生命徵象。

(9) 依醫囑給予藥物，包括支氣管擴張劑、祛痰劑、抗生素等。

3. 體液容積太多／與心肌收縮力減弱有關

(1) 評估周邊組織水腫的程度（如四肢及陰囊等），以及頸靜脈怒張的情形。

(2) 每日測量腹圍及體重。

(3) 監測強心劑及（或）利尿劑使用藥效。

(4) 使用利尿劑者需密切觀察有無副作用（如低血鉀）之發生。

(5) 視病人情況評估輸入及輸出量。

(6) 採坐臥時，協助病人抬高水腫的肢體，並注意水腫皮膚之護理。

(7) 視病人之症狀教導病人限水及（或）採低鈉飲食（3-5gm／天）。

4. 活動耐力不足／與氧的供需不平衡、疲憊或電解質障礙有關

(1) 活動前、後測量生命徵象並比較差異，必要時監測心電圖改變。

(2) 測量體重。

(3) 安排營養師給予飲食諮詢，並監測病人進食之質與量。

主題名稱	心衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/12

- (4) 每日協助教導自行翻身及執行關節運動。
- (5) 抬高床頭。
- (6) 協助採漸進性活動。
- (7) 討論調整活動的必要性以減少心臟工作負荷的要求並發展個別化及漸進式的活動。
- (8) 依醫囑服用藥物可促進活動的耐力。
- (9) 向病人或家屬說明活動耐受力之影響因子。
- (10) 教導學習或練習鬆弛技巧以避免促使活動無耐力。
- (11) 教導病人心臟代償的警訊。
- (12) 教導當引起疼痛或疲累時，便終止或減少活動。
- (13) 教導監測自己對活動的生理反應，有助於評估日常生活活動度。
- (14) 判斷病人或配偶是否有性諮商的需要，適時給予資訊。

5. 焦慮感受／與呼吸困難有關

- (1) 提供機會讓病人說出焦慮原因。
- (2) 以平靜溫和的態度來照顧病人，對於病人的疑問，盡可能立即予以回答。
- (3) 視病人需要予以解釋疾病的過程、各項檢查與治療的目的及注意事項。
- (4) 協助病人減輕呼吸困難等不適之症狀，以減輕其焦慮情形。
- (5) 評估病人過去面對壓力所使用之因應策略，並協助其運用可行的支持系統及因應策略，來調適目前疾病對其生活所造成的限制。

(七) 衛教指導

1. 飲食：應控制飲食的量

- (1) 採低鈉鹽食物，一天勿超過 3-5 公克（約一小湯匙）；避免食用高鹽及醃製品，如：魯味、醬油、醬菜、蜜餞等食物。
- (2) 採低油脂、低膽固醇飲食，烹煮時可用植物油取代避免食用動物內臟及小魚乾、蝦米等食物。
- (3) 多食用富含纖維質的食物，如深綠色蔬菜、水果等，以保持排便的順暢，避

主題名稱	心衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/12

免因用力解便而造成心臟的負荷。

(4)維持理想體重，應控制三餐飲食及熱量；限制醣類及動物性脂肪。

(5)吃完飯後，不可立刻工作，應休息 30-60 分。

2. 水分攝取的監測：

(1)依照個人情況來限制水分，每日 1000-1500cc。

(2)每日清晨起床解尿後及進食早餐前，應測量體重並做紀錄。

(3)若體重迅速增加（一天增加超過 1 公斤），呼吸急促、喘到無法平躺睡覺等症狀，須嚴格限制鹽與水。

(4)每天觀察水分的攝取量及尿液排出量是否平衡。

(5)每日觀察下肢是否有凹陷性水腫。

3. 活動

(1)輕度心臟衰竭的病人，可照常上班；但活動量則以自己感覺呼吸困難、疲憊、頭暈、胸悶等症狀出現的嚴重度作調整。

(2)嚴重心臟衰竭的患者，則依自己的感覺呼吸困難的程度採漸進性活動。若有呼吸困難情形，可搖高床頭及使用氧氣，以減輕心臟負荷。

(3)於床上休息時，應翻身或移動肢體，增加四肢的活動，減少周邊血管血液鬱積，預防血栓靜脈炎。

4. 藥物服用的重要性及注意事項：

應按照醫生指示定時服藥，包括：毛地黃、利尿劑等；勿自行停藥、改變藥量或亂服成藥，以避免病情加重或毛地黃中毒。包括使用利尿劑時，會使身體內的電解質如鉀、鈉，隨水份排掉，所以在平常的飲食上，須補充含『鉀』的食物，如香蕉、柳丁、橘子、蕃茄等水果；使用毛地黃時應學會自我監測脈搏，若心跳次數少於 60 下，須告知醫護人員。

5. 日常生活保健：

(1)避免太冷太熱，溫差太大、空氣不好的環境，如：洗三溫暖。

(2)保持心情愉快，不可太勞累。

主題名稱	心衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/12

- (3)戒煙及避免吸二手煙：吸煙是造成冠狀動脈疾病的危險因素，應禁止吸煙，以避免心臟的負擔。
- (4)控制高血壓及其他相關疾病（如前述之貧血、甲狀腺機能亢進、腎臟疾病）等。
- (5)在能力、體力範圍內，從事適量之運動，以增加活動耐力及生活品質。
- (6)避免閉氣時用力的活動，例如：用力排便。
- (7)保持規律的生活，早睡早起，最好於上午及、下午各安排有一次短暫的休息及睡眠。
- (8)定期回門診追蹤及調整藥物。
- (9)當病人出現以下症狀加重時，必須通知醫師：
- A. 稍做活動，即感胸痛、呼吸困難、心跳加速。
 - B. 腳踝水腫、腹脹、噁心、疲憊。
 - C. 尿量減少。
 - D. 體重快速增加，每日超過 1-2 公斤。
 - E. 平躺時覺得呼吸不順，須墊高枕頭才能入睡。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）蔡育倫、黃淑玲、林維祥（2022）。急性心衰竭之性別差異。醫療品質雜誌，16(3)，

主題名稱	心衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	9/12

90-93。

(二) 王奕鈞、廖大銘、陳杰(2024)・簡介心衰竭的臨床診斷與處置・臺灣醫界,67(2), 22-24。

(三) 王宗道(2023)・心臟跳不停?小心是「心衰竭」警訊!健康世界,(560),45-47。

七、附件

(略)

主題名稱	心衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	10/12

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 醫護部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	(1)Diuril 改 Lasix (2)增加說明內容的修辭。	100 年 08 月 31 日 醫護部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	(1)配合本院 SOP 格式改版。 (2)增加說明內容的修辭。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭。	102 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	更新第六項參考資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	1. 新增參考文獻資料於內文中。 2. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日 護理長會議通過。
108.06.06	3.5	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議通過； 108 年 06 月 12 日 護理長會議通過； 108 年 06 月 18 日 督導會議通過公布。

主題名稱	心衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	11/12

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.07	3.6	第三項第三目合併「護理部_A31000-Q03-W-B05_充血性心衰竭」說明內容。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過；110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.01.04	3.7	依疾病照護認證建議修訂第三項全目說明內容，以及修訂第六項參考資料內容。	110 年 12 月 02 日照護標準組會議通過；110 年 12 月 08 日護理長會議通過；111 年 01 月 04 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.8	NANDA 護理診斷更新為護理問題。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.10.15	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	3.9	1.第三項第五目、第六目第 1、2 點：標點符號修訂。 2. 第三項第六目：錯字修訂。 3. 第六項參考資料修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。

主題名稱	心衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	12/12

修正日期	版本	修正說明	備註